

Contraindicaciones absolutas y relativas de las vacunas

1. Introducción y relevancia clínica

Las vacunas son intervenciones médicas extremadamente seguras, pero **existen situaciones específicas en las que su administración está contraindicada o debe postergarse temporalmente**, ya sea por riesgo de efectos adversos graves o por interferencia en la respuesta inmunológica.

El **MINSAL (PNI 2025)** y la **Organización Mundial de la Salud (OMS)** establecen criterios claros para **contraindicaciones absolutas, relativas y precauciones**, con el fin de evitar errores que pueden tener consecuencias graves.

En el **EUNACOM**, este tema es recurrente en preguntas del tipo:

“Niño con fiebre, madre embarazada, inmunodeficiencia, o antecedente de reacción adversa postvacunal. ¿Se aplica o no la vacuna?”

Por tanto, conocer las indicaciones precisas **evita suspender innecesariamente una vacuna segura** o, al contrario, **administrar una vacuna peligrosa en condiciones de riesgo**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

Las reacciones adversas graves a las vacunas suelen estar relacionadas con:

1. **Hipersensibilidad tipo I (anafilaxia):** reacción inmediata a un componente del preparado (proteínas del huevo, gelatina, antibióticos residuales).
2. **Inmunosupresión severa:** riesgo de enfermedad diseminada ante vacunas **vivas atenuadas**.
3. **Embarazo:** posible daño fetal ante exposición a virus o bacterias vivos.

Las contraindicaciones deben distinguirse de las **falsas contraindicaciones**, que no implican riesgo y no deben retrasar la vacunación.

3. Clasificación de las contraindicaciones

a. Contraindicaciones absolutas

Estas situaciones **prohíben completamente la administración de una vacuna específica**:

Situación clínica	Vacuna involucrada	Explicación
Reacción anafiláctica grave a dosis previa o componente (huevo, gelatina, neomicina, látex, etc.)	Cualquier vacuna con el componente	Riesgo vital
Inmunodeficiencia severa (congénita o adquirida)	Vacunas vivas (BCG, SRP, varicela, rotavirus, polio oral)	Riesgo de infección diseminada
Embarazo	Vacunas vivas atenuadas (SRP, varicela, fiebre amarilla)	Riesgo teórico fetal
Encefalopatía no explicada dentro de 7 días post DTPa	DTPa, dTpa	Riesgo de recurrencia
Alergia severa a proteínas del huevo o antibióticos específicos (ej. neomicina, polimixina B)	Influenza, SRP, varicela (según formulación)	Confirmar tipo de reacción
Anafilaxia al látex	Vacunas con tapón de caucho natural	Contactar laboratorio o usar alternativa

❑ **Nota:** Las alergias leves (urticaria, rinitis, prurito) **no contraindican vacunación**.

b. Contraindicaciones relativas o temporales

Son situaciones que **recomiendan posponer la vacunación** hasta resolución, o en las que se debe evaluar riesgo-beneficio.

Situación	Conducta	Observaciones
Fiebre alta (>38,5 °C) o enfermedad aguda grave	Postergar vacunación hasta recuperación	No aplica a cuadros leves
Uso reciente de inmunoglobulina o transfusión sanguínea	Postergar vacunas vivas (SRP, varicela) por 3–6 meses	Los anticuerpos pasivos pueden neutralizar el virus vacunal
Uso de corticoides sistémicos en dosis inmunosupresoras	Postergar vacunas vivas hasta 1 mes tras suspensión	Dosis: >2 mg/kg/día o >20 mg/día por >14 días
Prematuridad <32 sem y peso <1.500 g	Postergar BCG hasta estabilidad clínica	Resto de vacunas se aplican según edad cronológica
Síndrome de Guillain-Barré reciente (<6 sem)	Precaución con vacunas DTPa e influenza	Evaluar con especialista
Embarazo (precaución)	Solo aplicar vacunas inactivadas (dTpa, influenza, RSV)	No administrar vivas
Exposición reciente a radioterapia o quimioterapia	Postergar vacunas vivas 6–12 meses	Sistema inmune deprimido

4. Falsas contraindicaciones

Muchos mitos y errores conducen a suspender vacunas innecesariamente.

Las siguientes **NO son contraindicaciones** (MINSAL, OMS, CDC):

Situación	Conducta
Resfrío leve o fiebre <38,5 °C	Vacunar igual
Tratamiento con antibióticos	Vacunar igual
Historia familiar de alergia, convulsiones o muerte súbita	No contraindica
Lactancia materna	No contraindica (incluso favorece respuesta inmune)
Desnutrición leve o moderada	No contraindica
Enfermedad crónica estable (asma, cardiopatía, diabetes)	Vacunar
Uso de anticonvulsivantes o antitérmicos	No afecta eficacia
Prematurez (excepto BCG en <1.500 g inestable)	Vacunar según edad cronológica

5. Manejo en caso de inmunosupresión y embarazo

a. Niños inmunodeprimidos

- **Evitar vacunas vivas:** BCG, SRP, varicela, rotavirus, polio oral.
- Se pueden usar **vacunas inactivadas o recombinantes** (ej. hepatitis B, influenza, neumococo).

- Los contactos familiares sí pueden recibir vacunas vivas (excepto polio oral), ya que no representan riesgo.

b. Embarazadas

- **Permitidas:** dTpa (desde 28 semanas), influenza, RSV.
- **Contraindicadas:** SRP, varicela, fiebre amarilla (salvo riesgo vital).
- Si se administran inadvertidamente, **no está indicado el aborto terapéutico**, solo observación.

6. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

Generalmente **no se requieren exámenes previos** a la vacunación, excepto:

Situación	Examen sugerido
Inmunodeficiencia sospechada	Hemograma, inmunoglobulinas, linfocitos T/B
VIH confirmado	CD4 absoluto y porcentaje
Alergia severa previa	Test cutáneo o evaluación alergológica
Post transfusión	Registrar fecha para programar vacuna viva

7. Complicaciones y pronóstico

Las complicaciones graves derivadas de la administración de vacunas en condiciones contraindicadas son **muy infrecuentes**, pero pueden incluir:

- Infección diseminada (BCG en inmunodeprimidos).
- Encefalopatía post DTPa.
- Reacción anafiláctica grave.

Pronóstico: excelente si se respetan las contraindicaciones y se maneja adecuadamente cada evento adverso.

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

□ Perlas:

1. **Anafilaxia a componente vacunal = contraindicación absoluta.**
2. **Vacunas vivas (BCG, SRP, varicela, rotavirus) están prohibidas en inmunodeprimidos y embarazadas.**
3. **Uso reciente de inmunoglobulina o transfusión** inactiva las vacunas vivas → posponer 3–6 meses.
4. **Prematuros pueden recibir todas las vacunas según edad cronológica**, salvo BCG si <1.500 g.
5. **Resfrío o antibióticos NO son contraindicación.**
6. **dTpa e influenza son seguras en embarazo.**
7. **Reacción local o fiebre leve postvacunal no impide refuerzos posteriores.**

□ Errores frecuentes:

- Suspendir vacunas por cuadro respiratorio leve.
- Administrar BCG en prematuro inestable o <1.500 g.
- Aplicar SRP o varicela en embarazadas.
- Reiniciar esquema innecesariamente tras interrupción.
- No vacunar a hijos de madres VIH+ pese a estar sanos.

9. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Las **contraindicaciones absolutas** son pocas: **anafilaxia, inmunodeficiencia severa, embarazo (vacunas vivas) y encefalopatía post DTPa**.
2. **Vacunas vivas atenuadas** (BCG, SRP, varicela, rotavirus) están contraindicadas en inmunodeprimidos y embarazadas.
3. **Fiebre leve, antibióticos, lactancia o desnutrición** no son motivos para suspender vacunas.
4. **BCG se posterga en RN <1.500 g o inestables**.
5. **Inmunoglobulina o transfusión** → posponer vacunas vivas 3–6 meses.
6. **Embarazadas**: dTpa, influenza y RSV son seguras y recomendadas.
7. En caso de duda, **evaluar riesgo/beneficio y consultar al PNI o especialista**.